

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS 22231696425 / 551

FRANCISCO TADEU PEREIRA

IDADE: 68 PESO: 92 ALTURA: 165 PROFISSÃO: mestre obra (6-18h)

SINTOMAS: Refluxo / Sono fragmentado

QUEIXAS: Sonolência / mmII edemaciado / Pensadele

MEDICAMENTOS: Euthyrox / Cardedilol / Inspira / Diaminon / glifage.

MÉDICO: Dr. Gisela

MARCAPASSO: () S (X) N / COMPANHEIRO(A) USA MARCAPASSO: () S (X) N

EXERCÍCIO FÍSICO: Não

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: S JANTAR: N

HORA QUE DORME: 20 - 21 HORA QUE ACORDA: 4 - 4:30

COCHILLO (X) SIM () NÃO DORME ACOMPANHADO () SIM (X) NÃO () EVENTUAL

BEBIDA ALCOÓLICA (X) SIM () NÃO NA SEMANA () NÃO F. semana

FUMO () SIM () NÃO / DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO: 2X

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: 90 cm CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não MALLAMPATI: IV IAH: 6,5 SPO2: 81%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS:

CIRURGIAS: () NASAL () AMIGDALECTOMIA

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: IMC:

COMORBIDADE: (S) RESPIRATÓRIA (S) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA HAS

(N) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS Arritmia

18/09 Hc + 2 anos começou a roucar e ter
24 Sonolência.
Avaliação

24/09/24 P= 6-10 cm H₂O / Agosto 7-12 cm H₂O

IAH= 3 e/h

m de uso: 6h36'

fuq: 2,8 l/m

Bem adaptado

Natasha

02/10

24

P= 10 cm H₂O

IAH= 1,4 e/h

m de uso: 11h

Bem adaptado, relata
estar dormindo direito
que

17/10/24

P= 10 cm H₂O

IAH= 1,3 e/h

m de uso: 6h49'

fuq: 17,7 l/m

Bem adaptado

S/ queixas

Natasha

22/11

24

P= 10 cm H₂O

IAH= 1,9 e/h

m de uso: 6h35'

fuq: 27,1 l/m

Oriento ajuste de
marcador

Natasha

28/03/25 P=10 cmH₂O

TAH=1,6 e/h

mdc ure: 7h 1'

fuga: 33,6 l/m

Ben adaptada

Ajuste máscara

Natasha

04/04/25 P=10 cmH₂O

TAH=1,2 e/h

mdc ure: 6h 24'

fuga: 22,9 l/m

Natasha

27/06/25 P=10 cmH₂O

TAH=0,8 e/h

mdc ure: 7h 31'

fuga: 26,8 l/m

Natasha

Descrição do Exame Polissonográfico

Nome: FRANCISCO TADEU PEREIRA			
Sexo: M	Idade: 68 anos	Peso: 93 Kg	Altura: 1.65 m
IMC: 34.2	Data do Exame: 19/08/2024	Exame: 13694_01	

COMENTÁRIOS:

Exame iniciado às 10:38:14 PM horas e encerrado às 6:01:03 AM horas, com latência para o sono de 80 minutos e latência para o sono REM de 315 minutos. O tempo total de sono foi de 358.0 minutos, com eficiência do sono de 80.4%. A distribuição dos estágios do sono mostrou:

Estágio do sono	% encontrada	% prevista *
Estágio 1	0.4%	Até 5%
Estágio 2	94.7%	45 - 55%
Estágio 3	1.5%	> 15%
Sono REM	3.4%	20 - 25%
Eficiência do sono	80.4%	> 85%

No tempo acordado após o início do sono – WASO 7 minutos ocorreram **394 despertares (índice de 66.0 /hora)**.

Durante o registro, a frequência cardíaca média foi de 68 bpm, a maior de 75 bpm e a menor de 63 bpm.

Foram identificados **0.0 movimentos periódicos de membros inferiores/hora, e 0.0/hora associados a despertares.**

Ocorreram 367 eventos respiratórios, sendo 0 central e 367 obstrutivos. Sendo 359 apnéias, 8 hipopnéias e 0 RERAS. O **Índice de Distúrbios Respiratórios (IDR) total foi de 61.5/hora**, sendo 60.2 apnéia/hora e 1.3 hipopnéia/hora e 0.0 RERAS/hora. A duração média dos eventos respiratórios foi de 28.2 e a duração máxima de 48.5.

O índice de apnéia/hipopnéia no sono REM foi 80.0/hora, sendo 80.0 apnéia/hora e 0.0 hipopnéia/hora. O índice de RERA no sono REM foi de 0.0. Ocorreram 0 RERAS com tempo médio de 0.0 segundos, com duração máxima de 0.0 segundos.

A **saturação basal da oxihemoglobina foi de 96%**, sendo a saturação média de 90%, a maior de 97% e a mínima de 81%, permanecendo 106.8 minutos (24.0%) de registro com a saturação abaixo de 90% e 0.0 minutos (0.0%) com a saturação abaixo de 80%. Ocorreram 370 dessaturações. Índice de dessaturações: 62.3/hora. Índice de dessaturações no sono REM: 40.0/hora. Índice de dessaturações no sono Não REM: 63.0/hora.

Resumo dos resultados

- 1 - Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau acentuada (normal até 5/hora). Todos os eventos foram do tipo obstrutivo.
- 2 - Dessaturações da Oxihemoglobina.
- 3 - Ronco presente.
- 4 - Sono fragmentado pelo aumento no número de despertares breves (normal até 10/hora).
- 5 - Eficiência do sono reduzida.

Henrique Pedro Magoga Filho
Otorrinolaringologia /
Distúrbios Respiratórios do Sono
CRM-SP 129264

CONTRATO
1. DADOS DA LOCADORA
NOME: Faria e Matos Comércio de E.
CNPJ: 13.181.388/0001-27
ENDEREÇO: R. -
CEP:



CENTRO DIAGNÓSTICO EM CARDIOLOGIA ANDRÔMEDA
DR GISEL PEREIRA CALDAS JUNIOR
TITULAR EM CARDIOLOGIA - SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA
RQE - REGISTRO QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALISTA - 19.739
CRM-SP- 49.112

Estágio 1	84,7%	45 - 50%
Estágio 2	1,5%	> 15%
Estágio 3	3,4%	20 - 30%
Sono REM	80,4%	> 80%

S J CAMPOS, 10 / SETEMBRO / 2024

FRANCISCO TADEU PEREIRA

SONOFISIO

Endereço: R. Santa Elza, 418

Resumo dos resultados

- 1 - Índice de Apnéia-Hipopnéia de grau acentuado (normal até 50%). Todos os eventos foram do tipo obstrutivo.
- 2 - Desaturações da Oxihemoglobina.
- 3 - Ronco presente.
- 4 - Sono fragmentado pelo aumento no número de despertares breves (normal até 10 horas).
- 5 - Eficiência do sono reduzida.